PLAIES, CICATRISATION, PANSEMENTS ET ESCARRES

Cours synthétique à partir des 13 vidéos de la playlist « Cours Plaies et Cicatrisation + Pansements »

Objectif. Comprendre les mécanismes de réparation, évaluer une plaie, contribuer au choix et à la réalisation du soin dans son cadre, prévenir les complications et transmettre une évolution utile.

Repères de formation

UE : B3 - Pratiques et interventions infirmières. Thème : plaies, cicatrisation, pansements et escarres. Public : étudiant infirmier de 1re année, référentiel 2026. Le soin est individualisé et s’effectue selon les compétences acquises, la prescription, le protocole et l’organisation du service.

Les 13 vidéos regroupées par thèmes

Bloc de vidéos	Notions reprises dans le cours
Histologie, physiologie, cofacteurs	Structure cutanée, phases de cicatrisation, facteurs qui facilitent ou retardent la réparation.
Pansements et traitements modernes	Objectifs du pansement, familles et limites, prise en charge étiologique des plaies chroniques.
Plaies chroniques et complexes	Évaluation, suivi, complexité, infection, coordination pluridisciplinaire.
Escarre et pied diabétique	Pression, catégories, prévention, décharge, repérage précoce et orientation.
Ulcère cutané, zona, antiseptiques	Distinguer les situations et retenir les précautions de soin.

Fil conducteur : évaluer la personne et la cause → décrire la plaie → définir l’objectif → réaliser le soin prévu → réévaluer, tracer et transmettre.

Limite documentaire. Les vidéos sont des supports pédagogiques secondaires. Cette synthèse les organise par thème et les complète par des références professionnelles; elle ne prétend pas retranscrire mot à mot les interventions.

1. ÉVALUER LA PERSONNE ET LA PLAIE

Une observation structurée permet de comparer les soins dans le temps et de transmettre des faits.

Commencer par la personne

Recueillir les informations utiles : douleur et vécu du soin, mobilité, autonomie, alimentation et hydratation, maladies connues (dont diabète ou maladie vasculaire), traitements, allergies, état général, objectifs et ressources. Identifier le mécanisme possible : traumatisme, chirurgie, pression, origine veineuse ou artérielle, pied diabétique, brûlure ou autre cause. L'étiologie doit être évaluée cliniquement; l'aspect seul ne suffit pas à poser un diagnostic.

Décrire toujours les mêmes éléments

Élément	À observer et noter
Localisation	Site anatomique précis; proximité d'un relief osseux ou d'un dispositif.
Dimensions	Longueur, largeur et profondeur si évaluable; même méthode et mêmes axes à chaque mesure.
Lit de la plaie	Tissus visibles : épithélialisation, granulation, fibrine, nécrose; cavité ou décollement si présent.
Berges et pourtour	Berges, macération, rougeur, fragilité, œdème, chaleur, sécheresse ou réaction à l'adhésif.
Exsudat et douleur	Quantité, aspect; odeur persistante après nettoyage si pertinente; douleur avant, pendant et après le soin.
Évolution	Comparer à l'évaluation antérieure : dimensions, aspect, tolérance, saturation/fuite du pansement.

Photographie. Elle ne remplace pas la description ni la mesure. Respecter le consentement, les règles institutionnelles et le dossier sécurisé.

2. COMPRENDRE LA CICATRISATION

Les phases se chevauchent; leur durée varie selon la plaie et la personne.

Phase	Mécanisme principal	Repère pédagogique
Hémostase	Vasoconstriction, agrégation plaquettaire et caillot.	Le saignement est limité; le caillot forme une matrice provisoire.
Inflammation	Défense locale et élimination des débris par les cellules immunitaires.	Rougeur, chaleur, œdème et sensibilité peuvent apparaître au début.
Prolifération / granulation	Néo-vaisseaux, fibroblastes et matrice de comblement.	Tissu rouge/rosé, fragile et vascularisé.
Épithélialisation	Migration des cellules épidermiques depuis les berges.	Recouvrement progressif de la surface.
Remodelage	Réorganisation progressive du collagène et de la cicatrice.	La cicatrice gagne en résistance sans redevenir identique à la peau.

Schéma de synthèse

Lésion	Hémostase	Inflammation	Granulation + épithélialisation	Remodelage
→	→	→	→	→

Facteurs de cicatrisation

Freins locaux	Freins généraux ou contextuels
Pression répétée, ischémie, infection clinique, tissu dévitalisé, excès d’humidité ou dessèchement, macération, traumatisme, corps étranger, douleur mal contrôlée.	Dénutrition ou apports insuffisants, diabète, tabac, œdème, déshydratation, maladie vasculaire, immunodépression, âge, traitements ou maladie aiguë.

Rôle infirmier. Repérer les facteurs modifiables ou préoccupants, les documenter et les transmettre à l’équipe. La prise en charge de la cause mobilise les professionnels concernés.

3. PLAIES AIGUËS, CHRONIQUES ET ÉTIOLOGIES

Une plaie chronique est une plaie dont la cicatrisation est retardée; la HAS utilise souvent un repère de 4 à 6 semaines selon l'étiologie.

Situation	Indices à faire préciser / transmettre	Enjeu de prise en charge
Plaie traumatique ou chirurgicale	Mécanisme, date, souillure, fermeture, douleur, saignement et état des berges.	Protéger, surveiller le risque infectieux et respecter le plan de soins.
Ulcère veineux	Souvent jambe distale avec œdème; rechercher les bilans et consignes existants.	Évaluer la cause veineuse; compression seulement après évaluation vasculaire et selon prescription/protocole.
Plaie artérielle / ischémique	Douleur, extrémité froide, coloration inhabituelle, nécrose ou pouls diminués si évalués.	Alerter sur une suspicion d'ischémie; éviter les gestes non prévus et obtenir une évaluation adaptée.
Pied diabétique	Neuropathie possible, points d'appui, déformation, chaussage, antécédent de plaie.	Décharge, évaluation vasculaire et infectieuse, coordination spécialisée.
Lésion de pression	Zone d'appui ou sous dispositif; rougeur persistante, atteinte cutanée ou profonde.	Décharger la zone et renforcer les mesures préventives individualisées.

À ne pas confondre

Une lésion de pression se décrit avec une classification spécifique des escarres. Une plaie veineuse, artérielle ou diabétique ne se « stade » pas selon cette classification. Un même patient peut cumuler plusieurs causes; documenter les indices sans conclure au-delà de son rôle.

Principe. Traiter le lit de la plaie sans agir sur la cause expose à une stagnation ou à une récidive. Les pansements sont une aide au soin, pas le traitement étiologique.

4. MICROBIOTE, INFECTION ET ALERTE

La présence de micro-organismes ne suffit pas à diagnostiquer une infection.

Niveau	Sens clinique
Contamination / colonisation	Micro-organismes présents; pas nécessairement de réaction tissulaire ni de frein à la cicatrisation.
Infection locale possible	Évolution défavorable, douleur nouvelle, chaleur, rougeur, œdème, pus, exsudat en hausse, tissu friable ou odeur persistante après nettoyage. Interpréter les signes ensemble.
Extension / atteinte générale	Rougeur qui s'étend, lymphangite, altération de l'état général, fièvre, frissons ou signes d'instabilité : évaluation urgente selon le circuit du service.

Points de prudence

- L'odeur seule, la couleur seule ou une culture positive ne prouvent pas une infection clinique.
- Des signes peuvent être atténués par une neuropathie, une ischémie ou une immunodépression.
- Un prélèvement microbiologique suit une indication, une prescription et le protocole local; il ne doit pas retarder une alerte nécessaire.
- Surveiller aussi saignement inhabituel, douleur disproportionnée, nécrose, dégradation rapide ou absence d'évolution attendue.

Antiseptiques : usage raisonné

Ne pas appliquer automatiquement un antiseptique à chaque pansement. Respecter l'indication, le produit, les incompatibilités, la durée et le protocole; le nettoyage/irrigation relève du protocole du service. Ne pas mélanger ni superposer des produits sans vérification.

Alerte rapide. Aggravation rapide, extension inflammatoire, signes généraux, suspicion d'ischémie, nécrose importante ou plaie du pied diabétique qui se dégrade : prévenir l'IDE responsable et le prescripteur selon l'organisation locale.

5. CHOISIR UN PANSEMENT : RAISONNEMENT

Choisir selon l’objectif, l’exsudat, le lit de la plaie, la peau autour et la tolérance.

Famille (repère)	Objectif habituel	Vigilance
Interface non adhérente	Limiter l’adhérence et le traumatisme au retrait.	Vérifier le pansement secondaire et la fréquence prévue.
Mousse absorbante	Gérer un exsudat modéré; protéger la plaie.	Réévaluer si saturation, fuite ou macération.
Hydrofibre / alginate	Absorber un exsudat plus important; certains produits peuvent aider à l’hémostase locale.	Ne pas utiliser sur plaie sèche sauf indication du produit; vérifier retrait et résidus.
Hydrogel	Apporter de l’humidité à une plaie sèche et contribuer à une détersion autolytique si indiqué.	Surveiller macération; respecter contre-indications et protocole.
Hydrocolloïde	Maintenir un environnement humide sur certaines plaies peu à modérément exsudatives.	Pas adapté à toutes les plaies; surveiller peau périphérique et signes d’infection.
Film / pansement transparent	Protéger une peau intacte ou une plaie superficielle sélectionnée.	Pouvoir absorbant limité; éviter sur exsudat important.

Avant de poser

- Définir l’objectif : protéger, absorber, préserver un tissu fragile, contrôler l’humidité ou faciliter le confort.
- Vérifier prescription/protocole, compatibilité des produits, dimensions, fixation, allergies et douleur.
- Ne pas tasser un pansement dans une cavité; respecter les consignes propres au dispositif.
- Après la pose, vérifier le confort, l’absence de compression et la bonne protection de la peau périphérique.

À retenir. Le pansement se choisit selon la plaie et son évolution, jamais uniquement selon le diagnostic ou une couleur de tissu.

6. ESCARRES : RECONNAÎTRE ET CLASSER

Lésion liée à la pression, seule ou associée au cisaillement; souvent située sur un relief osseux ou sous un dispositif.

Catégorie	Repère descriptif simplifié
1	Peau intacte avec érythème persistant non blanchissable; sur peau pigmentée, comparer aussi couleur, chaleur, consistance, douleur et œdème.
2	Perte cutanée partielle avec derme exposé; lit rouge/rosé, humide; pas de tissu adipeux ni structure profonde visible.
3	Perte tissulaire totale; tissu adipeux visible, sans muscle, tendon ou os exposé.
4	Perte tissulaire totale avec muscle, tendon, cartilage ou os exposé ou palpable
Non classable	Profondeur masquée par fibrine ou escarre; impossible à déterminer avant évaluation adaptée.
Lésion profonde suspectée	Décoloration persistante rouge sombre/violacée ou phlyctène sanguine sur zone de pression.

Prévention individualisée

- Évaluer le risque et le réévaluer si mobilité ou état clinique change; une échelle complète l’observation sans la remplacer.
- Inspecter les zones d’appui et sous les dispositifs; surveiller la peau et les talons.
- Réduire pression, friction et cisaillement; mobiliser/repositionner selon plan individualisé, capacités et tolérance.
- Maintenir peau propre et protégée de l’humidité; évaluer apports nutritionnels et hydriques; encourager la participation de la personne.
- Matelas et coussins adaptés complètent le plan, sans remplacer mobilisation et surveillance.

Ne pas faire. Ne pas masser une rougeur persistante. Ne pas attribuer une catégorie d’escarre à un ulcère d’une autre cause. En cas de doute, demander validation selon le protocole.

7. PIED DIABÉTIQUE ET AUTRES PLAIES CHRONIQUES

La perte de sensibilité peut retarder la découverte d’une plaie; une lésion peu douloureuse n’est pas forcément bénigne.

Surveillance du pied diabétique

- Observer les deux pieds : peau, espaces interdigitaux, ongles, callosités, déformations, zones d’appui et chaussage.
- Rechercher une plaie, une ampoule, un écoulement, une rougeur, une nécrose, une chaleur inhabituelle ou un pied froid/coloré.
- Prendre en compte neuropathie, artériopathie, antécédent d’ulcère ou d’amputation, infection possible et équilibre du diabète.
- Encourager l’inspection quotidienne et le chaussage adapté; une plaie doit être signalée et orientée dans un parcours de soins coordonné.

Orientation. La HAS recommande une prise en charge pluriprofessionnelle du pied diabétique et un examen régulier du risque podologique. Une plaie qui s’aggrave, une nécrose ou des signes d’infection/ischémie nécessitent une évaluation rapide.

Ulcères de jambe : cause et soin

L’ulcère veineux, artériel ou mixte nécessite un bilan de la cause. La compression ne s’instaure pas sans évaluation vasculaire et consignes adaptées. La plaie artérielle suspectée, surtout avec douleur, extrémité froide ou nécrose, doit être signalée rapidement. Le soin local accompagne la stratégie causale.

Plaie chronique complexe

Profondeur, perte de substance, douleur, exsudat, nécrose, infection possible, comorbidités, récidive ou absence d’évolution favorable peuvent justifier un avis spécialisé. Les traitements dits « modernes » ne remplacent ni évaluation, ni décharge, ni contrôle de la cause.

8. DÉROULEMENT DU SOIN ET TRANSMISSIONS

Avant - pendant - après : sécurité, confort, observation, traçabilité.

Étape	Actions infirmières / étudiantes
Avant	Vérifier identité, prescription ou protocole, allergies, douleur et matériel; expliquer le soin; installer et préserver intimité. Hygiène des mains et environnement préparé.
Pendant	Retirer le pansement avec douceur; observer le pansement retiré, la plaie et la peau autour; nettoyer selon le protocole; mesurer et décrire; respecter technique et produits autorisés; prévenir la douleur et le traumatisme.
Après	Poser le pansement prévu sans tension/compression inadaptée; éliminer les déchets; réinstaller; vérifier confort et sécurité; tracer le soin, les observations et les transmissions.

Transmissions utiles : faits, évolution, action

Exemple : « Plaie face interne de jambe, dimensions mesurées avec la méthode du service; exsudat plus abondant qu'au soin précédent, peau périphérique macérée, douleur 5/10 au retrait. Pansement saturé avant le délai prévu. IDE référente informée à 14 h; consigne reçue et surveillance prévue. »

Douleur et confort

- Évaluer la douleur avant, pendant et après le soin avec l'outil adapté.
- Informer, installer confortablement, anticiper les consignes antalgiques prescrites et éviter les retraits traumatiques.
- Respecter pudeur, consentement et participation; expliquer les observations sans annoncer un diagnostic non établi.

Traçabilité. Noter date/heure, mesures comparables, tissus, exsudat, peau périphérique, douleur, tolérance, pansement posé, incidents, alerte, personne contactée et consignes.

9. CAS CLINIQUES, MÉMO ET LEXIQUE

S’entraîner à observer, agir dans son champ, transmettre et réévaluer.

Situation	Analyse / conduite attendue
Pansement humide, peau blanche et ramollie	Penser macération ou exsudat mal contrôlé. Décrire après nettoyage, comparer aux mesures, protéger la peau selon protocole, réévaluer le choix et transmettre si aggravation.
Rougeur persistante sur sacrum	Décharger la zone, vérifier peau et installation, ne pas masser, appliquer le plan de prévention et transmettre.
Petite plaie plantaire indolore chez une personne diabétique	La faible douleur n’exclut pas une lésion importante. Évaluer signes associés, chaussage et appuis; signaler et orienter rapidement selon le parcours.
Plaie de jambe avec pied froid et zone noire	Faire suspecter une atteinte vasculaire grave sans conclure seul; prévenir rapidement l’IDE et le prescripteur selon le circuit.

À retenir par cœur

- Décrire avec une méthode constante; comparer dans le temps.
- Évaluer la personne et la cause, pas seulement le lit de la plaie.
- Les phases biologiques se chevauchent.
- Escarre : pression ± cisaillement; prévenir et décharger.
- Une culture ou une odeur seule ne suffit pas à diagnostiquer une infection.
- Choisir un pansement selon objectif, exsudat, tissus et protocole.
- Pied diabétique : toute plaie mérite une évaluation et un parcours adaptés.

Lexique express

Exsudat : liquide produit par la plaie. Granulation : tissu vascularisé de réparation. Épithélialisation : recouvrement de la plaie par l’épiderme. Macération : peau trop humide, blanchâtre et fragilisée. Décharge : réduction de la pression sur une zone. Cisaillement : glissement différentiel des tissus qui les déforme.

Références de travail

HAS, Les pansements : indications et utilisations recommandées (2010, has-sante.fr); HAS, Parcours de soins du patient adulte vivant avec un diabète de type 2 (2025, has-sante.fr); HAS, fiches d’évaluation du pied diabétique (has-sante.fr); EPUAP/NPIAP/PPPIA, International Pressure Ulcer/Injury Guideline, 4e édition (2026, internationalguideline.com); IWGDF, recommandations pied diabétique (2023, iwgdfguidelines.org); SFFPC et Assurance Maladie, ressources de pratique sur plaies chroniques (consultées le 22/10/2026, sffpc.org / ameli.fr).